

TEMA 6.47 • OTORRINOLARINGOLOGÍA

Otitis Media Crónica

PERFIL EUNACOM 6.01.1.004

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **Otitis Media Crónica (OMC)** se define como una inflamación persistente del oído medio que dura más de 3 meses. Al igual que la **Otitis Media Aguda** recurrente y la otitis media con efusión, su causa fundamental es la **disfunción tubárica** crónica.

Etiología y Microbiología

A diferencia de la otitis aguda, la OMC suele ser **polimicrobiana**. Al existir una perforación timpánica persistente, se mezclan microorganismos de la piel (conducto auditivo externo) con bacterias que ascienden desde la faringe por la trompa de Eustaquio.

TABLA 6.47.1: TIPO DE BACTERIA VS MICROORGANISMOS MÁS FRECUENTES

TIPO DE BACTERIA	MICROORGANISMOS MÁS FRECUENTES
Gram positivos	<i>Staphylococcus aureus</i> (muy frecuente)
Gram negativos	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (muy frecuente)
Otros	Proteus, Klebsiella y anaerobios

NOTA CLÍNICA

La disfunción de la trompa de Eustaquio impide la ventilación adecuada del oído medio, generando presiones negativas y acumulación de secreciones que terminan por cronificar la infección y perpetuar la perforación del tímpano.

Clínica y Presentación

El paciente suele tener una historia de **meses a años** de evolución. Los antecedentes de **Otitis Media Aguda** recurrente en la infancia son casi universales.

- Los síntomas principales incluyen:
- Otorrea:** Salida de secreción por el oído, que suele ser intermitente o persistente.
- Hipoacusia de conducción:** Debido a la perforación y al daño potencial en la cadena de huesecillos.
- Exacerbación con el agua:** El cuadro clínico empeora tras baños en piscinas, mar o incluso la ducha, ya que la entrada de agua facilita la sobreinfección.

Diagnóstico

- El diagnóstico es clínico mediante la **otoscopia**. Los hallazgos característicos son:
- Perforación timpánica:** De aspecto crónico (bordes epitelizados, sin signos de inflamación aguda reciente).
- Alteraciones de la mucosa:** Se puede observar una mucosa del oído medio engrosada o con pólipos inflamatorios.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si la perforación se localiza en la zona superior del tímpano (**zona atical** o pars flaccida), se debe sospechar inmediatamente un **Colesteatoma**.

Tratamiento de la OMC

El manejo sigue un orden escalonado:

- Antibióticos Tópicos (Elección):** El fármaco de elección es el **Ciprofloxacino** en gotas.
- Antibióticos Sistémicos:** Se reservan si el tratamiento tópico falla. Deben cubrir obligatoriamente *Pseudomonas* y *S. aureus* (ej. Cefepime, Imipenem o combinaciones como Cloxacilina + Ceftazidima).

- Cirugía:** La **Timpanoplastia** es el tratamiento definitivo para cerrar la perforación y, si es posible, mejorar la audición.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En presencia de perforación timpánica, **NUNCA** utilizar gotas que contengan **aminoglucósidos** (como Gentamicina o Neomicina), ya que son altamente ototóxicos y pueden causar hipoacusia neurosensorial irreversible al entrar al oído interno. El Ciprofloxacino es seguro.

Colesteatoma (Otitis Media Crónica Colesteatomatosa)

El colesteatoma es una variante peligrosa de la OMC. Consiste en la presencia de **epitelio escamoso queratinizado** (piel) dentro de las cavidades del oído medio.

Fisiopatología

El epitelio del oído medio es respiratorio (pseudoestratificado ciliado). Cuando la piel del conducto externo entra al oído medio (generalmente por una perforación o retracción timpánica), empieza a descamarse. Esta "queratina" o "caspas" acumulada forma una masa que secreta enzimas proteolíticas que **destruyen el hueso** circundante (huesecillos y hueso temporal).

Riesgos y Complicaciones

Es una patología grave debido a su capacidad erosiva, pudiendo causar: - Destrucción de la cadena de huesecillos (hipoacusia severa). - Laberintitis. - Parálisis facial (por erosión del canal del nervio facial). - Complicaciones intracraneales: **Meningitis**, absceso cerebral o trombosis del seno sigmoide.

Diagnóstico del Colesteatoma

- **Otoscofia:** Se observa una masa blanquecina (perla de queratina) o una perforación en el ático con restos epiteliales. A menudo requiere evaluación por especialista (Otorrinolaringólogo). - **Imagen:** Es obligatorio solicitar una **Tomografía Computarizada (TAC) de oídos/peñascos** para evaluar la extensión de la destrucción ósea y planificar la cirugía.

Tratamiento Quirúrgico

El tratamiento es **siempre quirúrgico** y debe ser prioritario para evitar complicaciones. Los objetivos son: 1. **Timpanoplastia:** Para reconstruir la membrana. 2. **Mastoidectomía:** Limpieza del hueso mastoideo si está afectado. 3. **Reconstrucción osicular:** Evaluación de la cadena de huesecillos para intentar recuperar la audición.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Ante un paciente con otorrea crónica que no responde a tratamiento, o que presenta una perforación marginal/atical, la derivación a Otorrinolaringología debe ser urgente para descartar colesteatoma.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Mujer de cuarenta y dos años con antecedente de otitis media aguda a repetición desde la infancia. Consulta por otorrea crónica del oído derecho de dos años, hipoacusia progresiva y que los síntomas empeoran después de bañarse. La otoscopia muestra una perforación timpánica de bordes irregulares. ¿Cuál es el tratamiento inicial de elección?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Otitis Media Crónica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- bacterias, dentro de las cuales el estafilococo y la pseudomona son los más frecuentes,
- que puede ser por gram negativo, incluso es más frecuente todavía que sea polimicrobiano,
- Su clínica habitualmente dura meses a años y como antecedente es muy frecuente que tiene
- Es frecuente también que venga con otorrea porque hay una perforación timpánica, así
- que drena y es muy frecuente también que venga con hipocusea de conducción y que los
- Y finalmente hay que saber cuál es el tratamiento de la otitis media crónica y sepan que sigue
- hay y el tamaño y la localización y finalmente nos vamos al tratamiento quirúrgico que suele

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (OTITIS MEDIA CRÓNICA)**PREGUNTA 1**

Mujer de cuarenta y dos años con antecedente de otitis media aguda a repetición desde la infancia. Consulta por otorrea crónica del oído derecho de dos años, hipoacusia progresiva y que los síntomas empeoran después de bañarse. La otoscopia muestra una perforación timpánica de bordes irregulares. ¿Cuál es el tratamiento inicial de elección?

- A)** Aminoglucósidos tópicos óticos por su amplio espectro antibacteriano
- B)** Ciprofloxacino tópico ótico, que cubre pseudomona y estafilococo sin riesgo de ototoxicidad
- C)** Amoxicilina oral como en la otitis media aguda
- D)** Timpanoplastia quirúrgica inmediata para cerrar la perforación
- E)** Observación y aseo del conducto auditivo sin antibióticos

PREGUNTA 2

Hombre de treinta y cinco años con otitis media crónica consulta por hipoacusia progresiva del oído izquierdo. La otoscopia realizada por el otorrino evidencia una perforación en la zona del ático timpánico y se aprecia material blancuzco a través del tímpano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el paso siguiente?

- A)** Miringitis bullosa: tratamiento con analgésicos y observación
- B)** Otitis media serosa: timpanometría y tubo de ventilación
- C)** Colesteatoma: solicitar TAC de hueso temporal e indicar cirugía
- D)** Otosclerosis: audiometría y considerar cirugía estapedial
- E)** Pólipo aural benigno: extirpación ambulatoria y alta

PREGUNTA 3

Paciente con otitis media crónica y colesteatoma confirmado por TAC. Además de la timpanoplastia, el cirujano evalúa si realizar también una mastoidectomía. ¿Cuál hallazgo justificaría indicar la mastoidectomía en este caso?

- A)** Hipoacusia conductiva documentada en la audiometría
- B)** Presencia de otorrea crónica purulenta por más de tres meses
- C)** Extensión del colesteatoma hacia las celdas mastoideas o presencia de absceso mastoideo
- D)** Perforación timpánica central de menos de dos milímetros de diámetro
- E)** Antecedente de otitis media aguda recurrente en la infancia

RESUMEN: OTITIS MEDIA CRONICA

Y las autitis no se acaban, seguimos ahora con autitis media crónica. Sepan que es causada por difunción tubárica, igual que la autitis media guarracurrente, igual que la autitis media conefusión, y que habitualmente está infectada con distintas bacterias, dentro de las cuales el estafilococohorius y la pseudomona son los más frecuentes, que puede ser por gram negativo, incluso es más frecuente todavía que sea polimicrobiano, o sea como hay una perforación habitualmente se meten los bichos de la piel, más los que vienen desde la garganta por la difunción tubárica y se mezclan todos ahí en el oído medio. Su clínica habitualmente dura meses a años y como antecedente es muy frecuente que tiene autitis media agudas recurrentes a repetición, justamente porque hay una difunción tubárica y a medida que se producen estas autitis media agudas recurrentes se termina por perforar y finalmente después de mucho tiempo esta perforación se vuelve crónica y ya no tiende a cicatrizar más. Es frecuente también que venga con otorrea porque hay una perforación timpánica, así que drena y es muy frecuente también que venga con hipocusea de conducción y que los síntomas aumenten al bañarse ya sea en el mar, en la piscina o después de bañarse en la ducha también. El denóstico se hace con la otoscopia y lo que se ve acá habitualmente es una perforación timpánica de aspecto crónico. Ahora cuando la perforación está en la zona más superior en el ático, una perforación atical, hay que sospechar inmedi